

20 - 03.1- Les Troubles Phobiques - Pr. LAFFINTI

Bonjour chers étudiants, nous continuons notre série de cours sur les troubles anxieux et nous enchaînons par le cours sur les troubles phobiques. Nous allons commencer par définir la phobie, qui correspond à une peur pathologique ou une crainte anxieuse qui est disproportionnée et qui est déclenchée par un objet ou une situation n'ayant pas en elle-même un caractère réellement dangereux. Cette peur est déclenchée immédiatement et quasi systématiquement après l'exposition à l'objet ou la situation phobogène.

Le sujet reconnaît généralement le caractère excessif de sa peur mais n'arrive pas à la contrôler. Cette peur va entraîner des comportements d'évitement ou des conduites contraphobiques de réassurance. Les troubles phobiques peuvent être classés en trois catégories.

D'abord l'agoraphobie, la phobie sociale, actuellement appelée anxiété sociale, et les phobies spécifiques, anciennement appelées phobie simple. Nous allons dans ce cours aborder les trois types de phobie. Nous allons tout d'abord commencer par l'anxiété sociale ou phobie sociale.

L'anxiété sociale peut être définie comme un trouble anxieux qui est caractérisé par une peur du regard d'autrui dans des situations d'interaction sociale. Cette peur est excessive, durable et gênante. C'est aussi la crainte d'agir de façon embarrassante et humiliante sous le regard et le jugement d'autrui.

Ce regard ou jugement peuvent être réels ou seulement supposés par le patient. Sur le plan épidémiologique, il faut savoir qu'il s'agit d'un trouble très fréquent dont la prévalence va de 5 à 12 % de la population générale selon les études mondiales. Il existe une prédominance féminine avec un sexe ratio de femmes pour un homme comme pour la plupart des troubles anxieux.

Les comorbidités sont également fréquentes, notamment les comorbidités avec les autres troubles anxieux, mais aussi les comorbidités très fréquentes avec les troubles dépressifs et aussi en termes de comorbidités avec les addictions et l'usage de substances psychoactives. Dans l'étude clinique, nous allons détailler la forme typique et citer quelques formes cliniques. Tout d'abord, nous commençons par le mode de début, qui est souvent progressif, avec apparition des troubles dans l'enfance et le début de l'adolescence, généralement entre l'âge de 10 à 15 ans.

Souvent chez un sujet ayant préalablement un tempérament anxieux ou une timidité préexistante, la peur va croître progressivement avec l'âge, surtout avec les confrontations sociales qui sont de plus en plus diversifiées et de plus en plus exigeantes, avec l'éloignement de la famille, les situations de prise de parole, mais aussi la rencontre avec le sexe opposé. Plus rarement, le début des troubles se voit à l'âge adulte, et généralement c'est dans une situation qui peut être traumatisante sur le plan de l'image de soi. Dans ce cas, l'anxiété sociale reste généralement limitée au même type de situation.

La forme typique est caractérisée par cette peur excessive et disproportionnée par rapport au danger réel de la situation redoutée, dont le sujet est conscient et reconnaît son caractère disproportionné, et à chaque fois qu'il y a une rencontre avec la situation redoutée, cette peur va déclencher instantanément et de façon quasi systématique une réaction anxieuse, dont les symptômes sont variables. Ce sont les symptômes de l'anxiété habituelle qu'on a déjà vus dans les précédents cours. Ces symptômes peuvent, dans certains cas, atteindre un degré maximum, celui d'une véritable attaque de panique.

L'anxiété va se traduire, bien sûr, sur les différents registres habituels. D'abord, sur le plan émotionnel, elle va se traduire par une tension nerveuse, avec un sentiment de peur, de honte, voire un sentiment d'humiliation. L'objet de la peur est ici toute agression verbale ou toute désapprobation sociale, c'est-à-dire tout ce que autrui pourrait dire de négatif sur la personne, et aussi un sentiment de honte qui est en lien avec la conviction qu'a la personne de n'avoir pas pu se conformer aux règles du groupe.

Donc, elle va avoir la certitude qu'elle est diminuée et qu'elle est dévalorisée par l'autre. Ces deux sentiments de peur et de honte vont coexister chez la personne. Le sentiment de peur va précéder la rencontre avec la situation et persister au cours de la situation sociale redoutée.

Et le sentiment de honte va se traduire pendant la situation, mais aussi après la situation sociale redoutée. Sur le plan cognitif, il existe chez le patient phobique social des schémas de pensée qui sont souvent irrationnels et non justifiés. Il y a des pensées négatives sur soi, mais aussi sur le jugement des autres.

Il s'agit d'une anxiété d'évaluation. Le patient est toujours dans cette crainte d'être jugé et évalué par autrui. Il est souvent convaincu qu'on va le juger négativement.

De ce fait, on va la rejeter comme personne et on va se moquer de lui. Ceci est sous-tendu par un trouble de l'estime de soi, avec une autodévalorisation. Cette faible estime de soi est quasi constante chez ces patients.

Aussi, il existe une anticipation négative de la situation sociale. C'est une sorte d'anxiété anticipatoire où le sujet va se dire je ne vais pas savoir quoi dire, je ne vais pas être à la hauteur ainsi de suite. Mais aussi des ruminations négatives qui se voient après la situation sociale.

Des ruminations concernant la performance du sujet au moment de l'exposition ou au moment de la situation sociale. Avec des propos de la sorte, j'étais tellement tendu, j'ai mal agi, les gens ont remarqué mon malaise ainsi de suite. Tout cela, bien sûr, va sous-tendre des troubles cognitifs de l'attention et de la mémoire.

Les troubles attentionnels sont accentués par une certaine focalisation sur soi, sur ses symptômes, sur son anxiété. Les sujets de phobie sociale, en situation sociale, vont être focalisés sur leurs symptômes et sur leur anxiété. Et cette anxiété va faire le lit d'une certaine

représentation négative que le sujet va imaginer, comment l'autre va le percevoir, comment l'autre va le juger.

Bien sûr, cette hyperconcentration sur soi au détriment des interactions sociales va limiter les possibilités du sujet au moment de la situation, au moment de la confrontation. L'anxiété va bien sûr se traduire aussi sur le plan physique par des symptômes variés. Dans le cas de l'anxiété sociale, c'est surtout une transpiration avec une sensation de main moite.

C'est aussi des bouffées de chaleur et aussi des tremblements des jambes, de la main, de la voix aussi avec des bégayements, une sensation de rougissement ou carrément de rougissement, des palpitations avec accélération du rythme cardiaque et aussi une tension musculaire. Comme on a dit, au maximum, les symptômes vont remplir les critères d'une véritable attaque de panique proprement dite. Sur le plan comportemental, l'anxiété liée à la phobie sociale va se traduire soit par une inhibition ou par une agitation anxieuse qui est stérile.

Mais surtout, elle va conduire la personne à adopter des comportements d'évitement. Ces comportements sont de plus en plus complexes, de plus en plus élaborés et récurrents et vont bien sûr aggraver le trouble et vont le pérenniser. Classiquement, on distingue deux types d'évitements dans le cadre de l'anxiété sociale, soit des évitements situationnels ou des évitements subtils.

Pour les évitements situationnels, le sujet va éviter toute confrontation avec la situation sociale redoutée. Il va par exemple renoncer à ou refuser une invitation. Il va renoncer à aller à une soirée ou à un repas en tête à tête.

Il va éviter de donner son opinion dans des situations où il doit s'exprimer. Ce sont des évitements qui sont assez manifestes. Le sujet va éviter complètement la confrontation avec la situation redoutée.

Les évitements subtils sont des évitements un peu plus élaborés. C'est plus des comportements de sécurité où le sujet, quand il se voit dans l'obligation de confronter la situation sociale, il va adopter certains comportements pour minimiser l'effet de l'anxiété liée à cette situation sociale. Par exemple, être présent dans une réunion, mais essayer de parler moins ou de ne pas contribuer aux conversations, de ne pas exprimer son opinion, peut-être aller à une soirée avec des amis et rester silencieux, ne pas participer.

Ou, par exemple, porter des vêtements ou des lunettes pour un peu minimiser l'effet de la rencontre avec la situation sociale. Ça peut aussi être se placer dans un endroit où il peut sortir rapidement en cas de malaise et ainsi de suite. Nous venons de voir la clinique de la forme typique, qui est la clinique type de l'anxiété sociale.

Concernant les sous-types, c'est essentiellement en rapport avec le degré d'envahissement de cette anxiété sociale sur la vie du sujet. Et on peut décrire classiquement le type ou le sous-type

dit généralisé, où le sujet va avoir cette anxiété, cette peur, cette crainte liée à la situation sociale dans plusieurs catégories de situations, généralement plus de trois domaines. C'est une forme qui est très sévère, dont le retentissement sur la qualité de vie du sujet et sur ses performances est assez important.

C'est une forme qui débute généralement à un âge très précoce, dès la première enfance, et bien sûr qui va aboutir à plus de complications, plus de retentissement avec un isolement et une perturbation assez significative de la vie du sujet. Et puis deuxièmement, le sous-type spécifique, où l'anxiété sociale va être en rapport avec une seule catégorie de situation ou seulement à une seule situation sociale, généralement une situation de performance. Donc c'est une forme qui est moins sévère, avec un retentissement moindre sur la qualité de vie des patients.

Ces catégories ou ces domaines où l'anxiété sociale va s'exprimer sont de plusieurs types. Ça peut être des situations de performance, ce sont les plus fréquentes, comme le fait d'exposer ou de faire une conférence, d'avoir un entretien d'évaluation, d'embauche, etc. C'est aussi des situations d'observation, où le sujet se sent sous le regard ou suppose être sous le regard d'autrui au moment où il accomplit une chose, c'est-à-dire manger en public, marcher, boire ou garer sa voiture.

C'est aussi des situations d'affirmation, où le sujet doit exprimer ou défendre ses droits, exprimer ses besoins, le fait de négocier, de prier, d'exprimer son décontentement ou son désaccord. C'est aussi des situations de révélation de soi, où le sujet doit se révéler ou rentrer plus profondément dans des choses plus intimes. Ça peut aller d'une relation amicale ou sentimentale, ou simplement le fait de faire de nouvelles connaissances ou de rencontrer quelqu'un pour la première fois.

Mais c'est aussi toute situation d'interaction, même superficielle, le fait d'échanger avec un voisin ou de parler avec quelqu'un, par exemple, lors d'un voyage dans un compartiment de train, etc. Après la clinique, nous allons aborder le chapitre du diagnostic, où on va voir le diagnostic positif et le diagnostic différentiel. Pour le diagnostic positif, il s'agit d'un diagnostic clinique qui va se baser sur les critères de la cinquième version du manuel « Diagnostic et statistiques des troubles mentaux », qui est la version la plus récente, écrite en 2003, dont les critères sont donnés à titre indicatif dans les deux diapositives suivantes et qu'on peut résumer ainsi.

C'est la présence d'une peur ou d'une anxiété importante de façon systématique qui sont disproportionnées dans une ou plusieurs situations sociales où le sujet craint d'être jugé négativement et qu'il va éviter ou subir avec une anxiété intense. Cette peur ou ces évitements sont persistants dans le temps, avec une durée minimale de six mois ou plus. Le critère de durée est un critère important pour retenir le diagnostic.

Il faut que cette peur ou ces évitements persistent au-delà de six mois pour retenir le diagnostic de l'anxiété sociale. Cette peur ou ces évitements entraînent une souffrance importante et

significative chez le sujet et ne doivent pas être liés ou dus à une autre affection mentale ou organique.